

ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ (PIS)
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੰਬਰ: ਸੰਸਕਰਣ 0.3 (16 ਦਸੰਬਰ 2024)

ਸਪਾਂਸਰ: ICMR

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ: ਡਾ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰਮ

ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ:

ਸਿਰਲੇਖ: ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੂਮ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਕਸੀਜਨ: ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ-ਆਰਮ, ਮਲਟੀ-ਸਾਈਟ, ਬੇਤਰਤੀਬ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਰਖ

ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: "ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੂਮ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਕਸੀਜਨ: ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ-ਆਰਮ, ਮਲਟੀ-ਸਾਈਟ, ਬੇਤਰਤੀਬ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਰਖ" ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਵਜੰਮੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ:

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਕ ਆਕਸੀਜਨ (ਹਾਈਪਰੋਕਸੀਆ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ (ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਕਾਗਰਤਾ (60% ਜਾਂ 90%) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 44 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ (ਜਿਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ)।

ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਰੀਸੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀ-ਪੀਸ ਰੀਸਿਊਸੀਟੇਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ (30% ਜਾਂ 60% ਜਾਂ 90%) ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਆਕਸੀਜਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੱਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਅੱਖਾਂ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 44 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ (ਇੱਕ ਆਮ ਪੂਰਨ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ) ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ 1996 (HIPAA) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਰਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 700 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾਖਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਬੇਆਰਾਮੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ 30% ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ 60% ਜਾਂ 90% ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਰੈਡੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੀਨਿਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਰਨਲ/ਬੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਸਮੂਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਅਤੇ 44 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮਆਰਆਈ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਇਹ ਅਧਿਐਨ 60% ਜਾਂ 90% ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਜੋਂ 30% ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪਕ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਧਿਐਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ:

ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਅਣਜਾਣ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਲਾਜ(ਵਾਂ) ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ, ਗਰੁੱਪ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਪਰਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (ਐਸਏਈ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੀਬਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ-ਇਸਕੇਮਿਕ ਐਨਸੇਫੇਲੋਪੈਥੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕੀਮੀਆ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਸ.ਏ.ਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਐਸ.ਏ.ਈ. ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਰਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਤੋਂ ਪਰਖ ਬੀਮੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ?

ਪਰਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ IEC (ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕੋ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ:

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਸੰਬੰਧੀ

ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਡਾ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ, ਡਾ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰਮ, ਸਹਿ-ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ:

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ:

ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰਮ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨਿਓਨੋਟੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ,

ਪੀਡੀਐਟ੍ਰਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਭੀੜ: 9478001129

ਈਮੇਲ: venkatpgi@gmail.com

ਸਹਿ-ਜਾਂਚਕਰਤਾ:

1. ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨਿਓਨੋਟੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਡੀਐਟ੍ਰਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
2. ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨਿਓਨੋਟੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਡੀਐਟ੍ਰਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
3. ਕੁਸ਼ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਰੇਡੀਓਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਐਂਡ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
4. ਸਮੀਰ ਵਿਆਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਰੇਡੀਓਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
5. ਵਨੀਤਾ ਜੈਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕਨਵੀਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ:

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਕੜ, ਡਾ.

ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 6006, 6 ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ,

ਰਿਸਰਚ ਬਲਾਕ ਬੀ, ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

ਸੰਪਰਕ: 0172-2755266

ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ (ICF)

ਅਧਿਐਨ ਸਿਰਲੇਖ: ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੂਮ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਕਸੀਜਨ: ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ-ਆਰਮ, ਮਲਟੀ-ਸਾਈਟ, ਬੇਤਰਤੀਬ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਰਖ

ਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: ਡਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰਮ (9478001129)

ਸਾਈਟ ਕੋ-ਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਮ: ਡਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ ਕੁਸ਼ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਡਾ ਸਮੀਰ ਵਿਆਸ, ਡਾ ਵਨੀਤਾ ਜੈਨ

ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦ: _____

ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: _____

ਉਮਰ: _____

ਜਾਣਕਾਰੀ	ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
1. ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਵਾਸਤੇ _____ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ	
2. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ	
3. ਮੈਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼(ਵਾਂ) ਲਈ ਹੋਵੇ	
4. ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ	

ਪਾਤਰ/ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ): _____

ਮਿਤੀ: ____/____/____

ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ: _____

ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: _____

ਮਿਤੀ: ____/____/____

ਅਧਿਐਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: _____

1) ਗਵਾਹ-1
ਦਸਤਖਤ

ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ:

2) ਗਵਾਹ -2
ਦਸਤਖਤ

ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ: